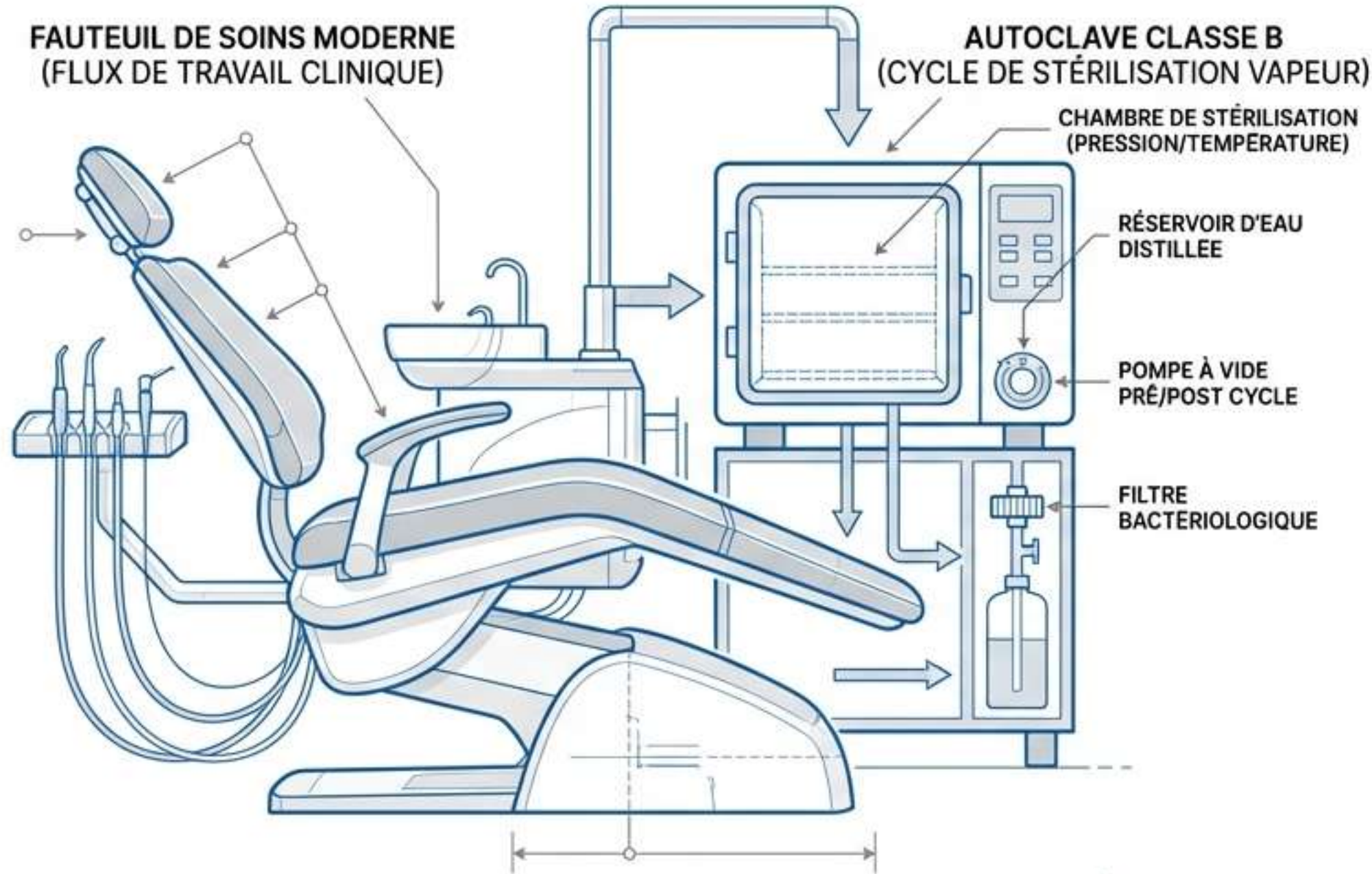


Antisepsie, Asepsie et Stérilisation au cabinet dentaire

Le Guide Intégral de Révision (Zéro Omission)



ANALYSE DES SUJETS PRÉCÉDENTS

(Contenu Jaune Strictement)

[EXAMEN 2024 QCM 15]

Définition exacte de l'asepsie vs. antisepsie (Piège classique sur les surfaces vs. tissus vivants).

[EXAMEN 2023 CAS CLINIQUE]

Protocole complet de stérilisation pour instruments critiques (Focus sur l'emballage et la traçabilité).

[EXAMEN 2022 SCHÉMA]

Identifier les différentes zones du cabinet dentaire selon le risque infectieux (Zone rouge, orange, verte).

PRÉDICTION DES PIÈGES FUTURS

(Contenu Vert Strictement)

[PIÈGE POTENTIEL 1 :
NORMES EN 13060]



Confusion entre les cycles de stérilisation B, S et N (Seul le cycle B est universel pour tous types de charges)

[PIÈGE POTENTIEL 2 :
GESTION DES DÉCHETS
(DASRI)]



Erreur sur la filière d'élimination des déchets piquants/coupants/tranchants (Conteneurs jaunes spécifiques)

[PIÈGE POTENTIEL 3 :
MAINTENANCE AUTOCLAVE]



Omission des tests périodiques obligatoires (Test de Bowie-Dick quotidien, Test Hélix hebdomadaire)

Cours de Pathologie Bucco-Dentaire - 2ème Année.

Dr. M.M. MEHDID, Pr. A. KADDOUR.

Année Universitaire 2025-2026.

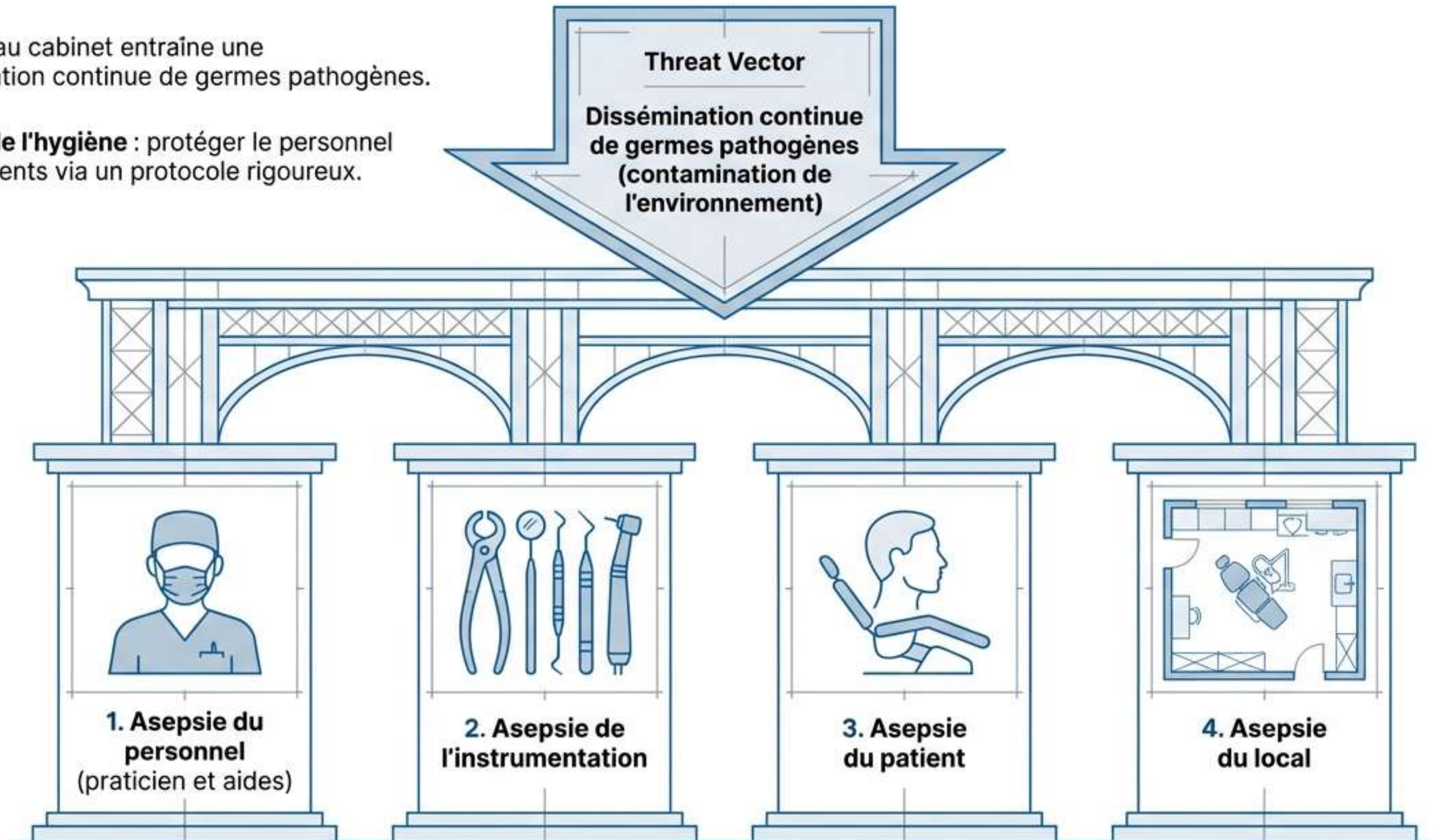
Faculté de Médecine Dentaire EHS MAOUCHE MOHAND AMOKRANE.

Conçu exclusivement pour la préparation aux examens.
Inclut une analyse des sujets précédents.

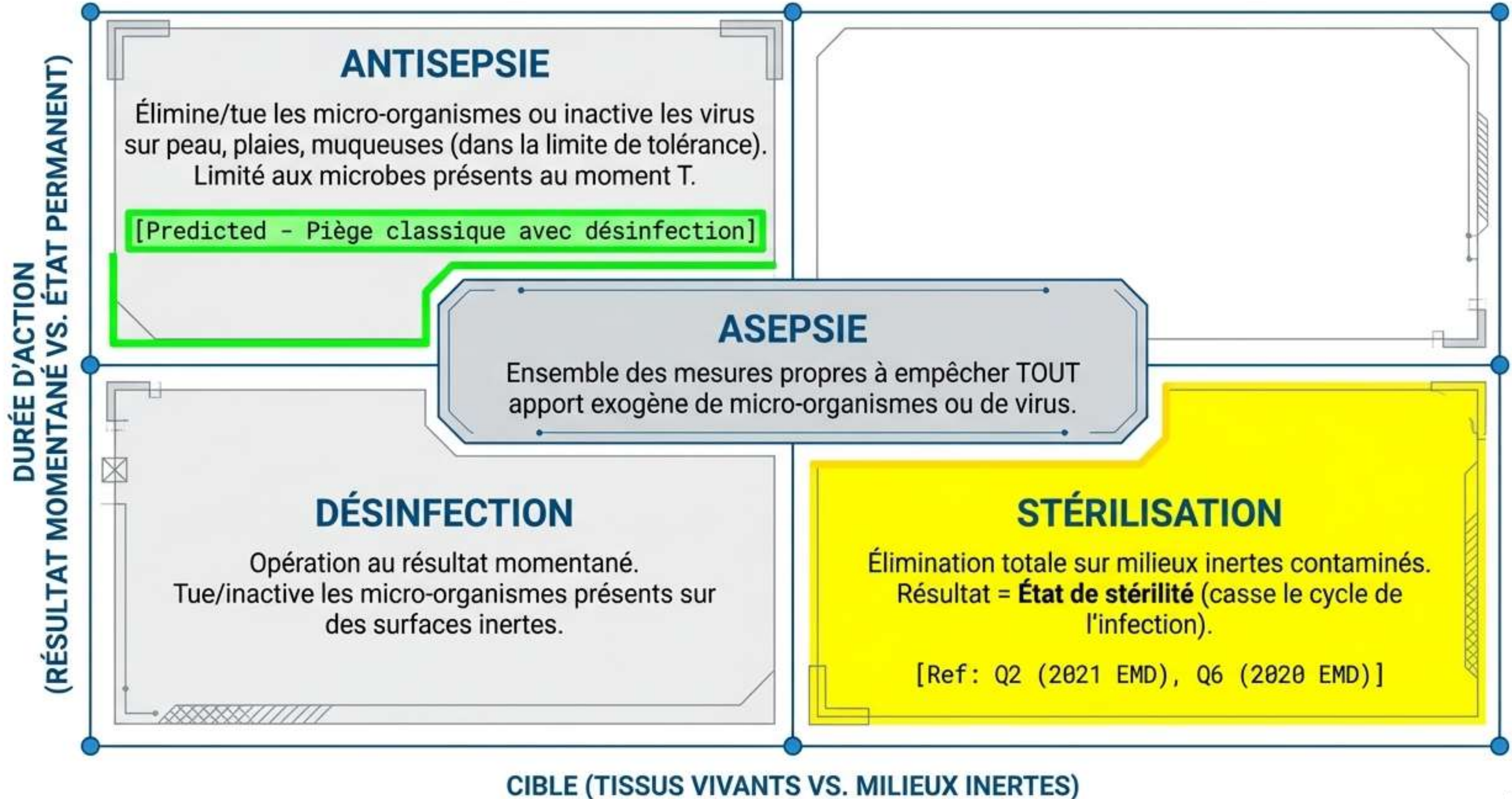
LA CHAÎNE D'ASEPSIE

L'activité au cabinet entraîne une dissémination continue de germes pathogènes.

Objectif de l'hygiène : protéger le personnel et les patients via un protocole rigoureux.

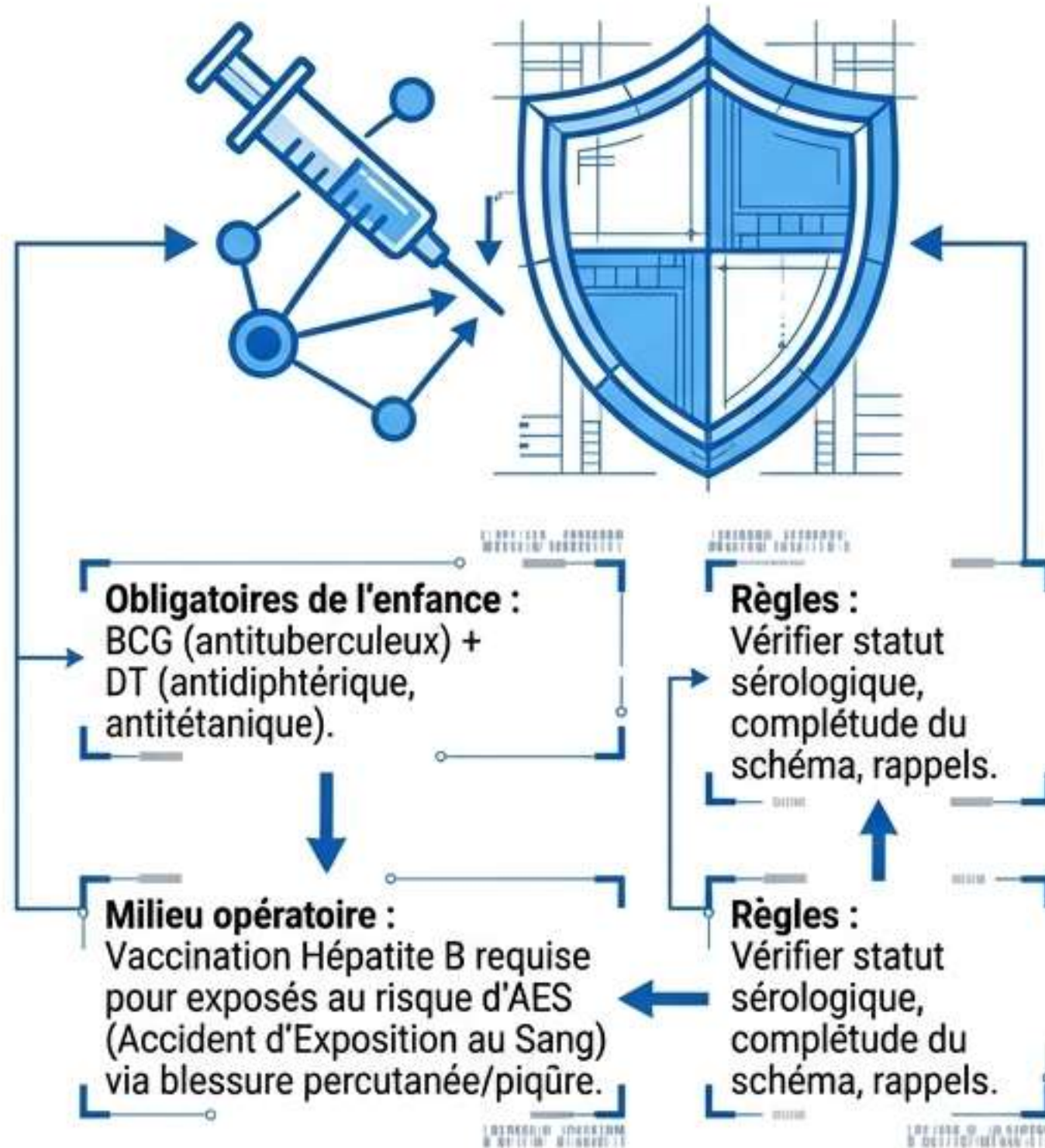


TERMINOLOGIE OFFICIELLE : NORMES AFNOR

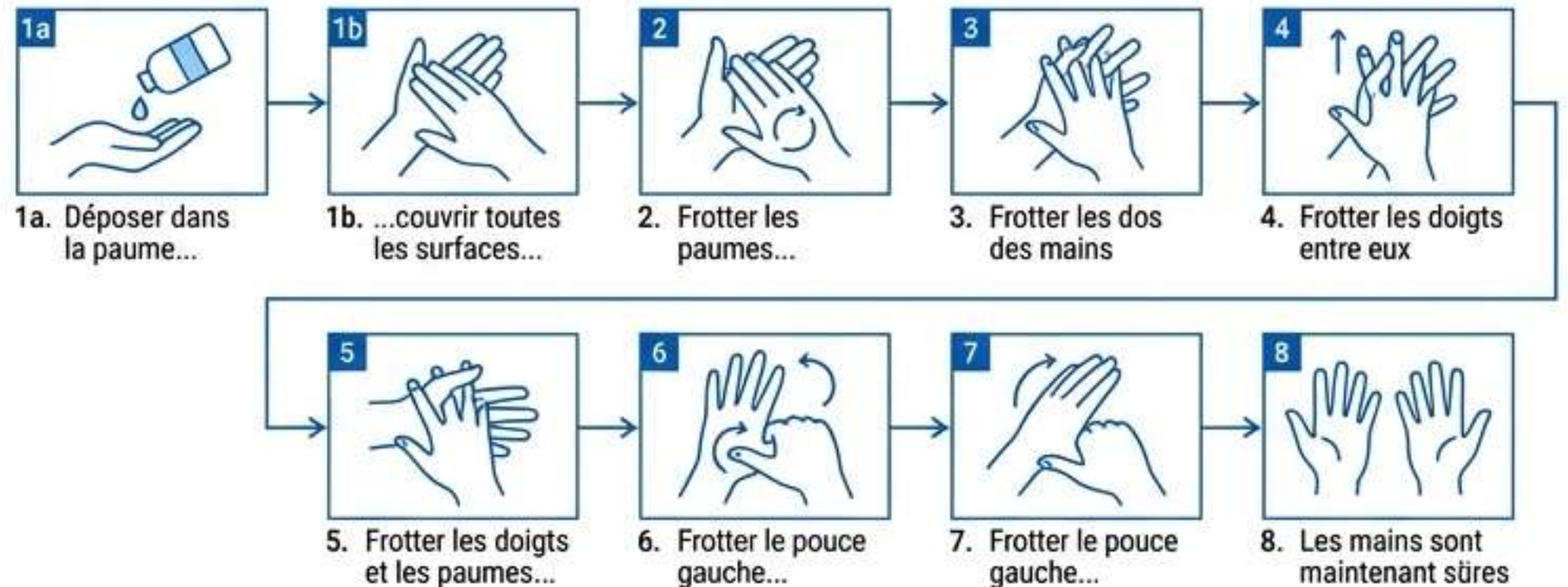


LE BOUCLIER HUMAIN I : IMMUNISATION & PRÉALABLES

1.1 Procédés d'immunisation



1.3 Préalables à l'hygiène des mains (Vecteur principal d'infections)



LE BOUCLIER HUMAIN II : LA TENUE RÉGLEMENTAIRE & LES GANTS

Calot:

Couvre entièrement tête/chevelure
(limite dispersion germes).

Lunettes/Visières:

Verre/plastique neutre, larges,
retour sur les côtés.
Systématiques pour actes invasifs.

Masque chirurgical:

Protège patient (postillons) et
praticien (aérosols des rotatifs).
Ne jamais toucher.

[Predicted - Chiffre testable]

Durée : ~3 heures



Tunique-pantalon:

Manches courtes (lavage aisé).
Changée quotidiennement.
+ Casaque chirurgicale (surblouse)
si acte invasif.

Chaussures dédiées:

Lavables. Recouvrent orteils/talons
(protègent chutes/liquides/piqûres).
+ Surchaussures (complément).

Gants:

Non stériles (liquides biologiques) vs
Stériles (produits stériles/actes haut niveau).
Précédés d'hygiène.

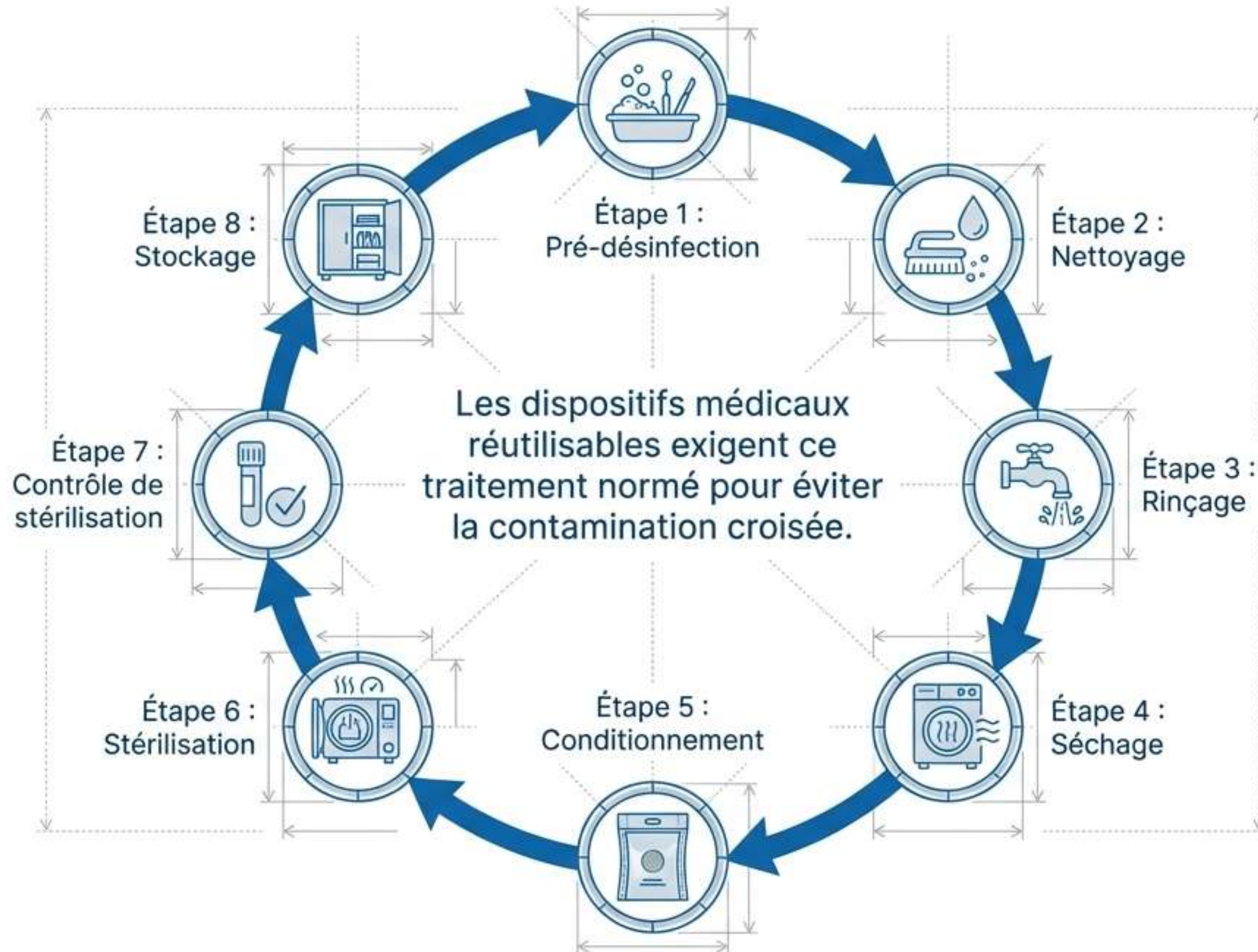
[Ref : Q12 (2023 RATT)]

Lavage des mains ne remplace pas les gants

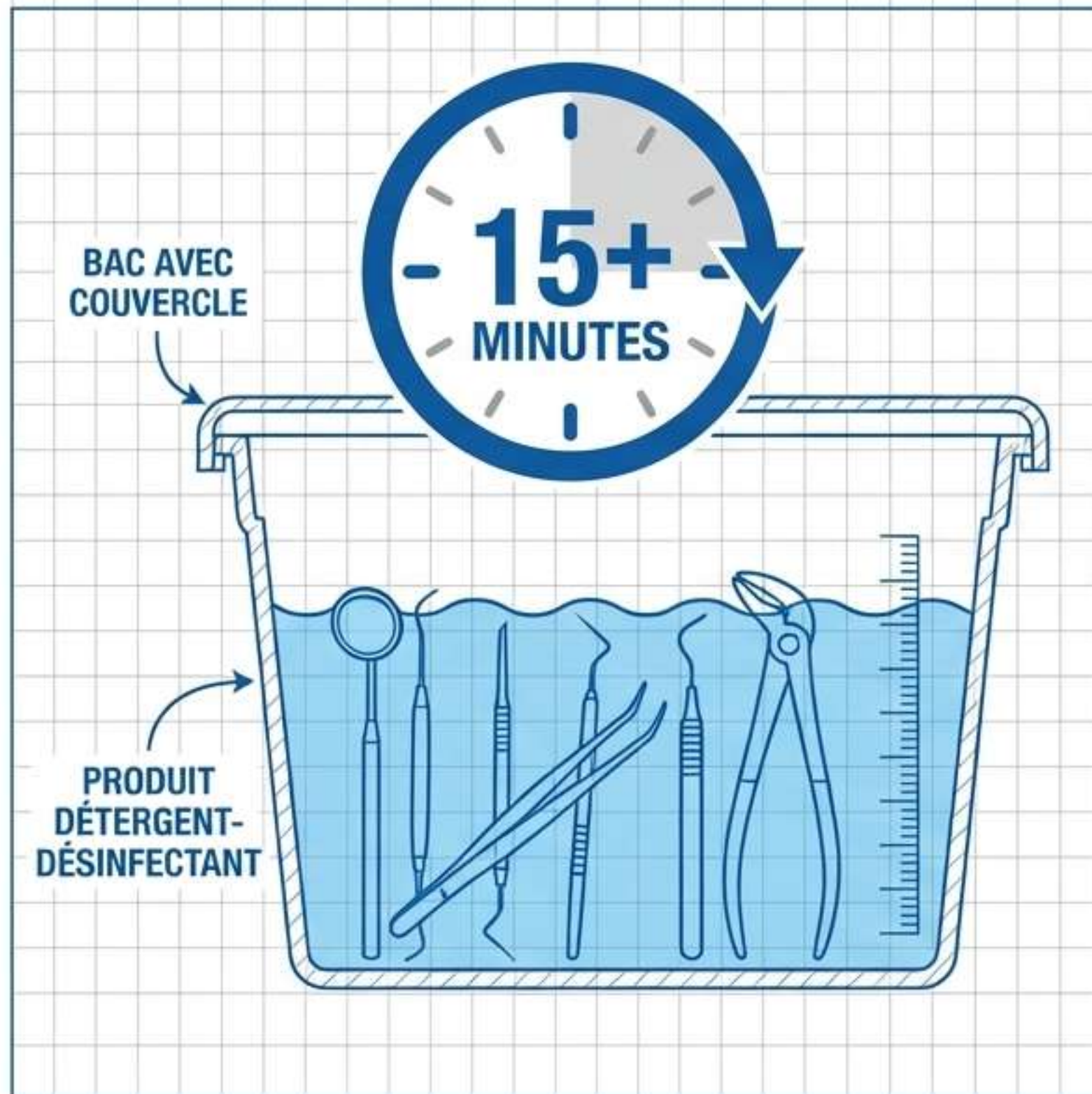
[Predicted - Piège MCQ]

Changement : 40-60 minutes ou si détériorés.
Lavage des gants strictement proscrit

LE CYCLE DE STÉRILISATION DE L'INSTRUMENTATION (VUE D'ENSEMBLE)



ÉTAPE 1 : LA PRÉ-DÉSINFECTION



RÈGLE D'OR : RÉALISÉE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE APRÈS USAGE.

OBJECTIFS MAJEURS :

Diminuer la quantité de salissures et réduire la charge microbienne initiale.

Faciliter le nettoyage en évitant le séchage des matières organiques [Ref: Q9 (2024 EMD), Q11 (2024 RATT), Q4 (2022 EMD)]

PROTOCOLE STRICT :

Immersion totale dans un bac avec couvercle.

Produit : Détergent-désinfectant (respecter dilutions du fabricant).

Temps de contact : Plus d'un quart d'heure (15 min) [Ref: Q9 (2024 EMD)]

PIÈGE D'EXAMEN :

Ne permet PAS d'obtenir un état stérile. Ce n'est qu'une étape préparatoire [Ref: Q4 (2022 EMD)]

ÉTAPE 2 & 3 : NETTOYAGE ET RINÇAGE

OBJECTIF NETTOYAGE : Actes mécaniques, chimiques, thermiques pour éliminer souillures (substrat aux micro-organismes).



N'élimine PAS toute flore microbienne
[Ref: Q11 (2024 RATT), Q13 (2022 EMD)]

 MANUEL	 ULTRASONS	 AUTOMATIQUE
● Détergent + brosse souple non métallique (éviter microfissures/biofilm). ● Long, fastidieux. ● Haut risque contamination. ● Protection requise (gants ménage, masque, lunettes). ● Utiliser le moins possible.	● Ondes de transduction (haute/basse pression). ● Décolle salissures en profondeur. ● Idéal pour petite instrumentation avec anfractuosités (fraises, forets).	● Thermo-désinfecteurs (principe machine à laver). ● Fait tout de la pré-désinfection au séchage.
 Combinaison optimale : Ultrasons + Lavage automatique [Predicted - Meilleure méthode]		

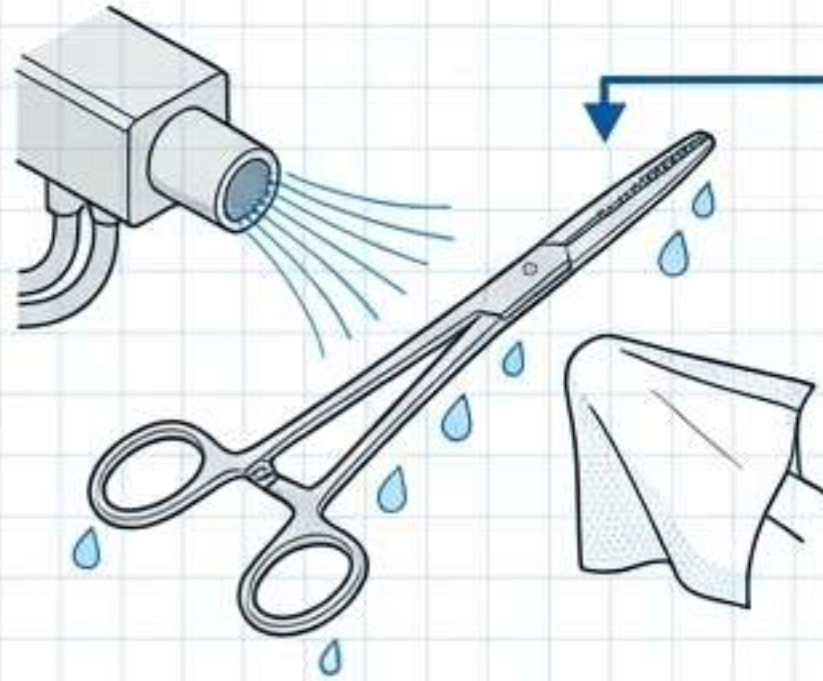
ÉTAPE 3 : RINÇAGE



- Obligatoire.
- Manuel/automatique à l'eau courante.
- But : Éliminer toute trace de désinfectant.

ÉTAPE 4 & 5 : SÉCHAGE ET CONDITIONNEMENT

ÉTAPE 4 : SÉCHAGE



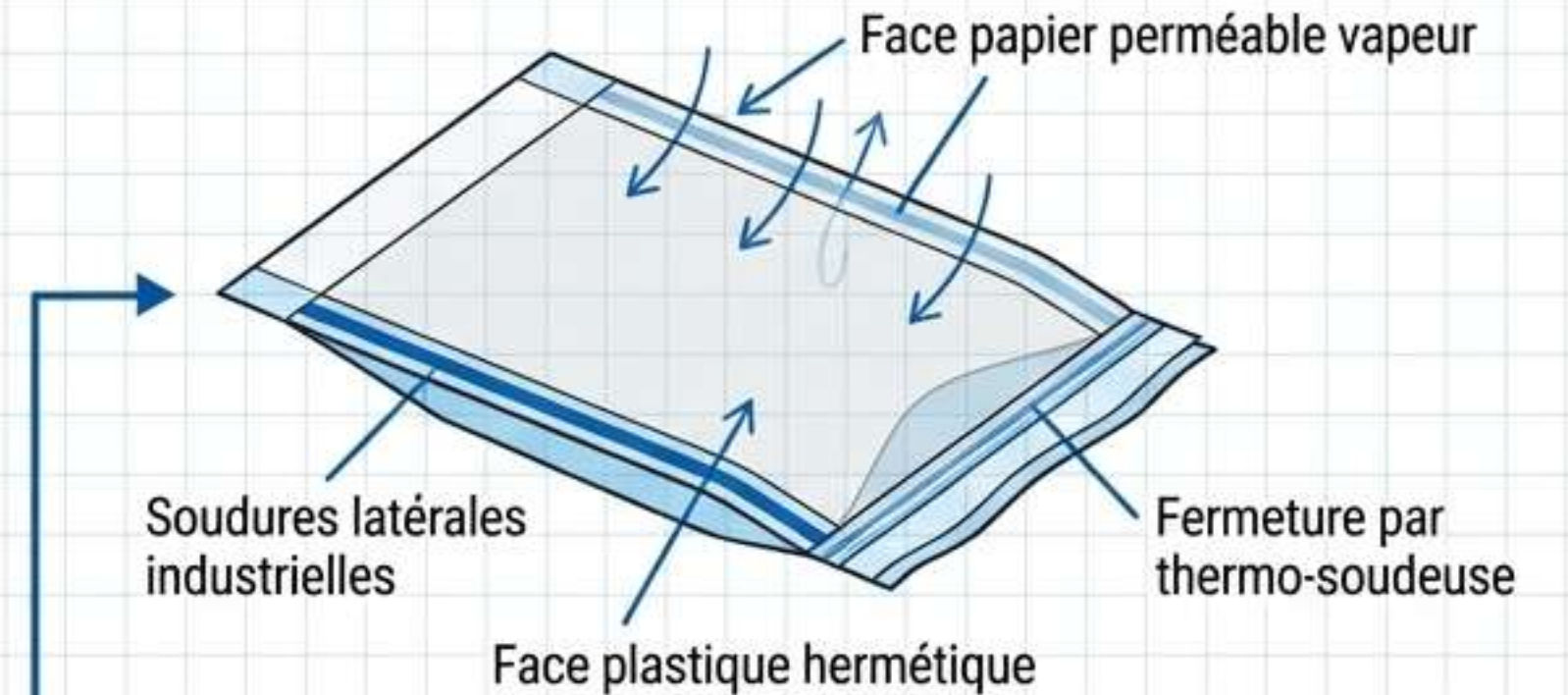
- **Méthodes** : Jet d'air chaud (bac de séchage) **OU** essuyage manuel (support non tissé, propre, usage unique).

- **Cibles prioritaires** : Charnières, parties rugueuses, embouts, pertuis (pour éviter l'oxydation).



Contre-indication absolue : Laisser sécher à l'air libre (recontamination garantie) [Predicted - Piège clinique]

ÉTAPE 5 : CONDITIONNEMENT



- **Règle** : Uniquement sur matériel propre et sec.
- **Matériaux** : Emballages rigides ou sachets thermo-soudés. Soudures latérales industrielles, fermeture par thermo-soudeuse.

But : Conserver l'état stérile APRÈS la stérilisation jusqu'au prochain usage [Ref: Q13 (2024 EMD)]

Les instruments "critiques" nécessitent une stérilisation **AVEC** emballage [Ref: Q11 (2023 EMD)]

ÉTAPE 6 & 7 : LA STÉRILISATION (PROCÉDÉ DE RÉFÉRENCE)

LE MATÉRIEL :

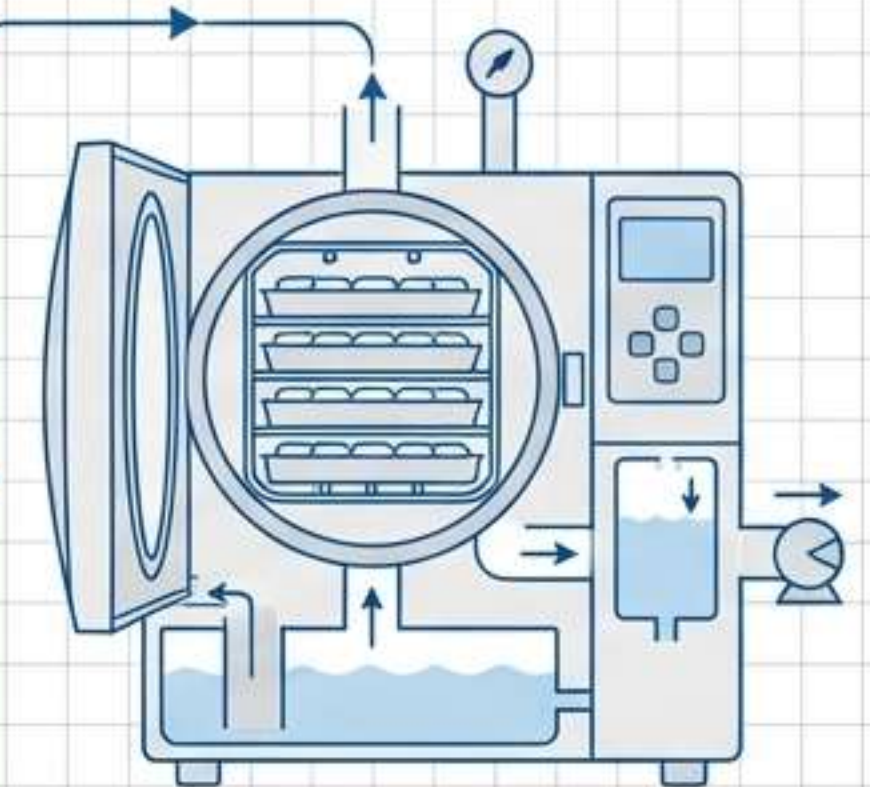
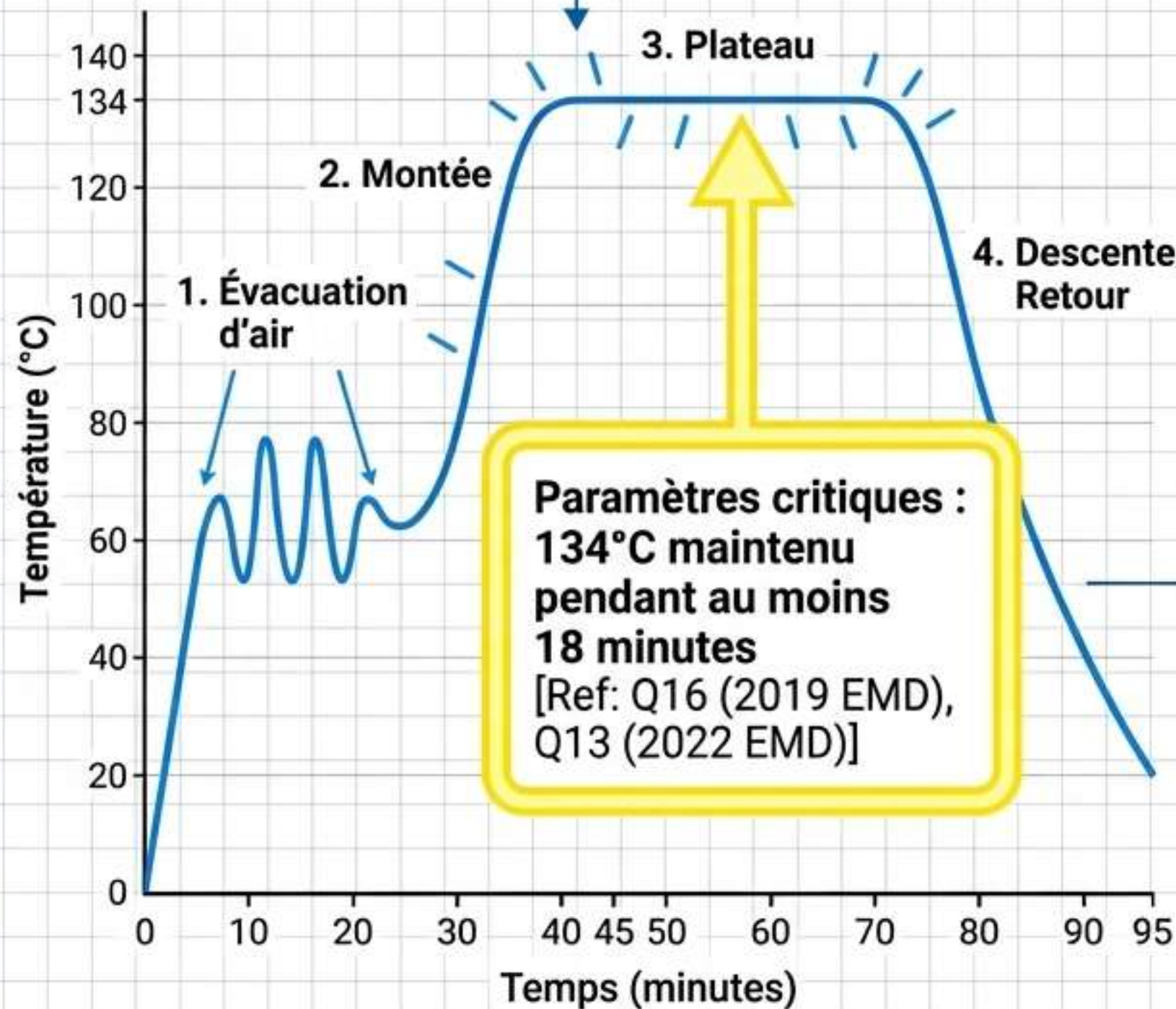
L'Autoclave de type B est le standard obligatoire pour le cabinet dentaire
[Ref: Q4 (2019 RATT), Q9 (2024 RATT), Q9 (2023 RATT)]

(Note: Poupinel / chaleur sèche est obsolète).

LE MÉCANISME :

Chaleur + Vapeur d'eau saturée provoque la destruction totale des germes
[Ref: Q18 (2023 EMD)]

Idéal pour champs, compresses, plastiques, caoutchoucs.



AUTOCLAVE CLASSE B

ÉTAPE 7 : CONTRÔLES :

- L'appareil doit être testé régulièrement pour assurer l'évacuation de l'air et pénétration de vapeur (Test Bowie-Dick, Test Hélix).

ÉTAPE 8 (STOCKAGE) & LE CAS PARTICULIER DES INSTRUMENTS ROTATIFS

ÉTAPE 8 : STOCKAGE

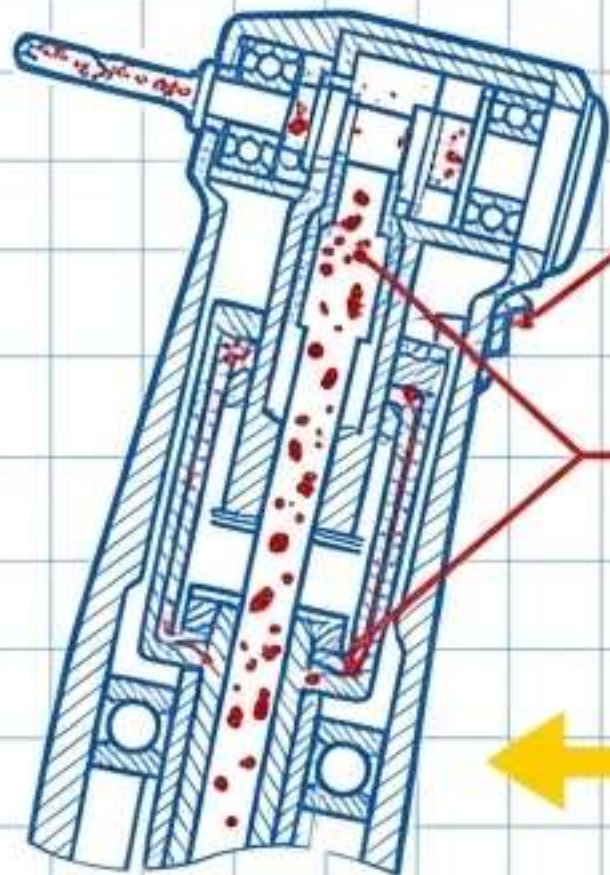


Endroit propre, sec, fermé
(armoire/tiroirs).

Règle logistique : Méthode
"Premier rentré, premier sorti"

Predicted - Piège clinique

LE CAS PARTICULIER DES INSTRUMENTS ROTATIFS



PURGE

Le Problème : Complexité interne.
Impossible de démonter. Souillés
à l'intérieur (sang, salive, débris).

Règle d'or : Ils SONT autoclavables.
La désinfection seule est insuffisante

Ref : Q7 (2020 EMD)

Procédure spécifique (4 étapes) :

1. **Purge :** Mécanique via l'eau (élimine particules internes, réduit colonisation des canalisations).
2. **Nettoyage externe :** Lingette désinfectante.
3. **Nettoyage interne automatisé :** Appareils dédiés (Assistina, Turbocid). Désinfecte et lubrifie (évite le grippage).
4. **Conditionnement et Stérilisation.**

LE TROISIÈME PILIER : ASEPSIE DU PATIENT

OBJECTIF : DIMINUER RISQUE CONTAMINATION PATIENT → PERSONNEL ET PATIENT → PATIENT.

TÊTIÈRE À USAGE UNIQUE :

Les cheveux retiennent/développent les germes. Housse obligatoire pour casser la chaîne croisée.

CHAMP OPÉRATOIRE :

Protège le site de l'environnement immédiat. Bavette large (usage unique, imperméable).

En chirurgie : Champ stérile obligatoire [Predicted]

ANTISEPSIE BUCCALE ET PÉRIBUCCALE :

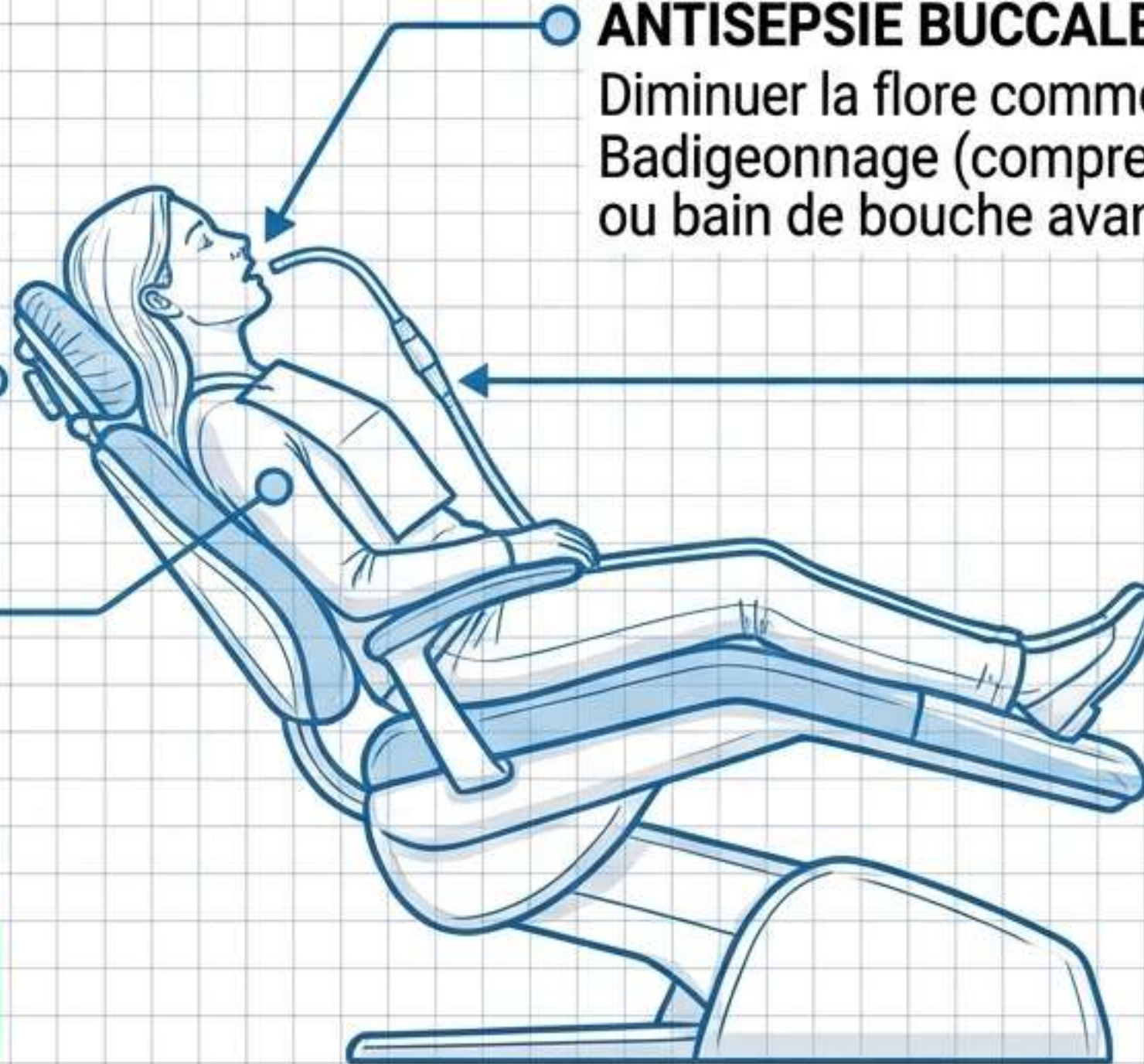
Diminuer la flore commensale (muqueuses, dents, peau). Badigeonnage (compresses stériles + chlorhexidine) ou bain de bouche avant traitement.

ASPIRATION EFFIQUE :

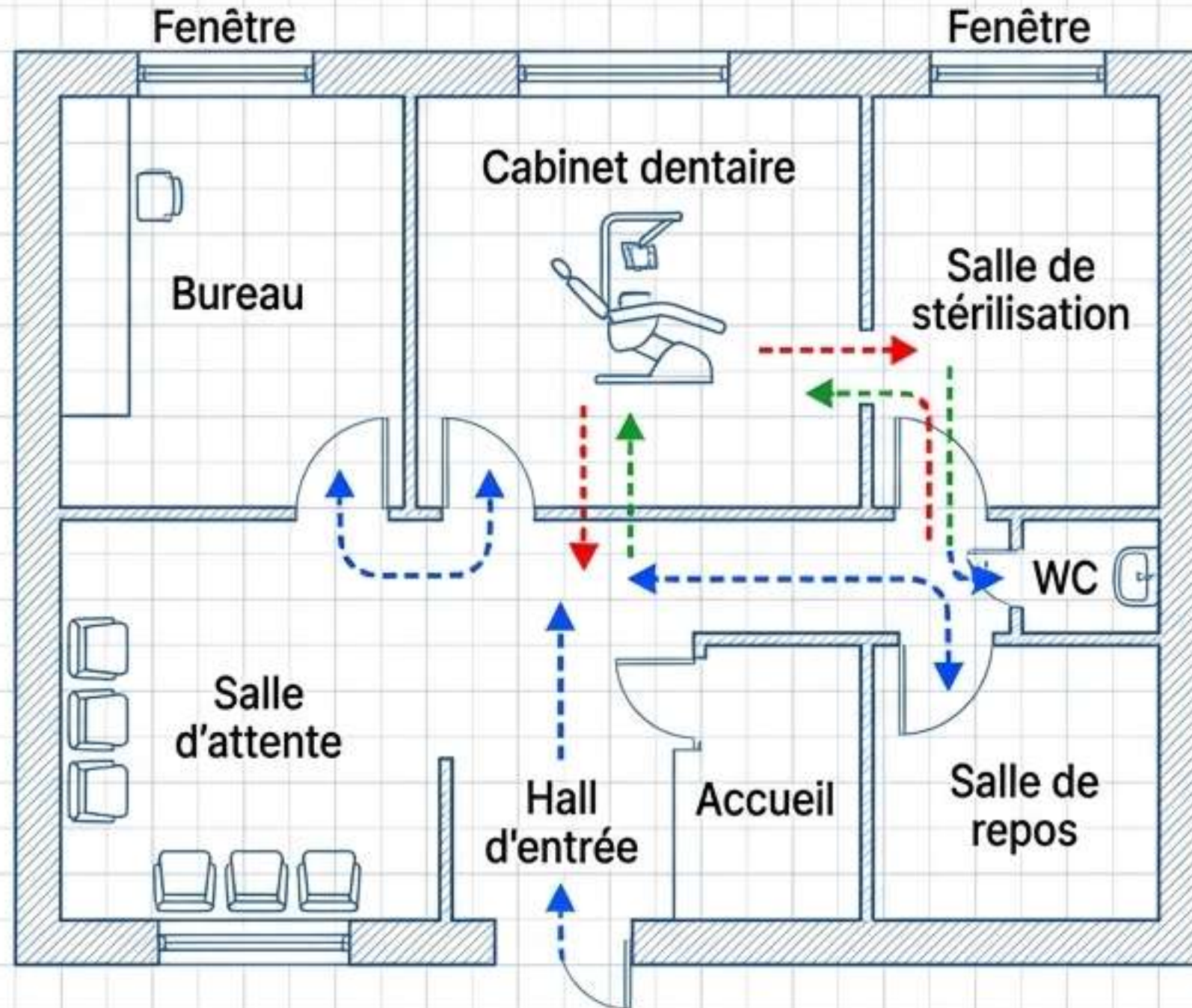
Lutte contre les aérosols et débris infectieux obligatoire.

ASPIRATION CHIRURGICALE :

Lutte contre les aérosols et débris infectieux environnementaux.



Le Quatrième Pilier : Asepsie du Local (Agencement)



- > Trajet du patient
- > Trajet des dispositifs médicaux souillés
- > Trajet des dispositifs médicaux stérilisés

L'Aménagement Spatial (selon risque) :

- **Zones administratives** : Accueil, bureau, attente.
- **Zones contaminées** : Salle de stérilisation (traitement), déchets, matériel ménage, sanitaires.
- **Zones protégées** : Salle de soins, conditionnement, stockage stérile/médicaments.

La Règle du Sens Unique :

Établir une circulation à sens unique du patient et des dispositifs médicaux [Ref: Q2 (2023 RATT)]

- Le patient ne doit JAMAIS croiser le cheminement de l'instrumentation souillée.
- Accès stérilisation interdit au patient (seul abord visuel par vitre toléré).

Asepsie du Local : Entretien et Risque Environnemental

Entretien par Zones

ZONE 1

Nettoyage quotidien dit domestique.

[Ref: Q11 (2024 RATT)]

ZONE 2

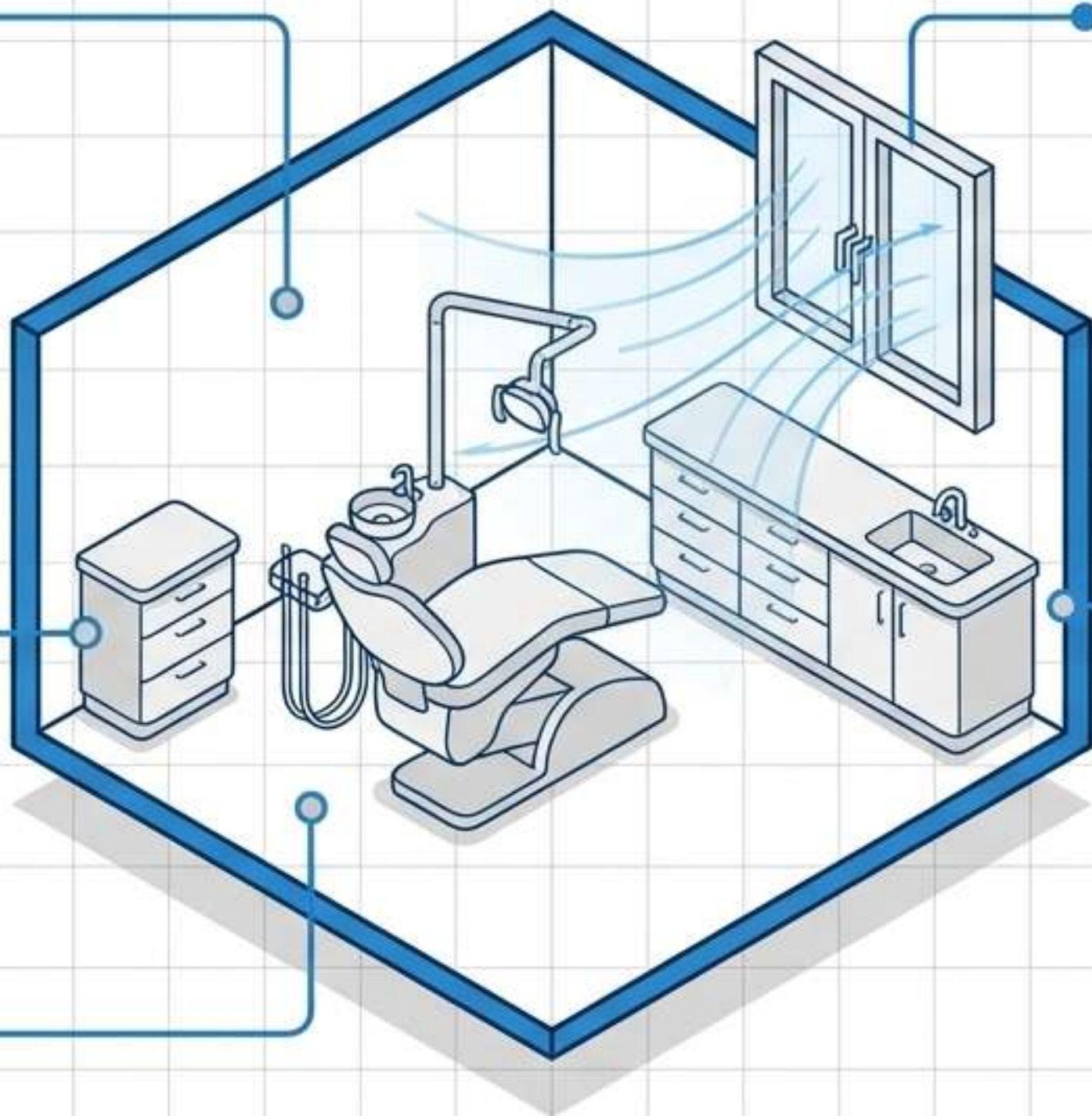
Bionettoyage quotidien avec produit détergent désinfectant normé.

[Ref: Q2 (2023 RATT)]

ZONE 3

Bionettoyage APRÈS TOUTE intervention avec produit détergent désinfectant normé

[Ref: Q2 (2023 RATT)]



Air et Recommandations

Qualité de l'Air :

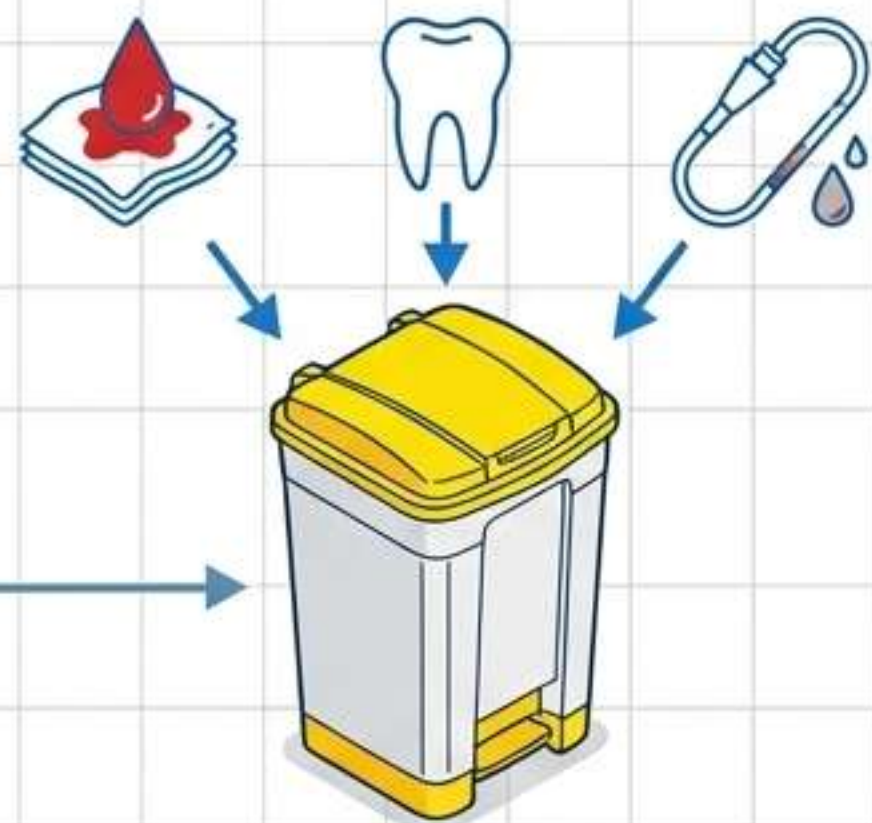
Renouvellement d'air : Aérer le matin et souvent (ou purificateur d'air).

Risque aérien n'est pas limité à la salle de soin
[Ref: Q2 (2023 RATT)]

Règles d'Aménagement :

- Mobilier à contours arrondis, parois lisses (pas de niches bactériennes). Éviter recoins.
- Éviter décorations accumulant poussière (tapis, plantes).
- Lavabos à commande au pied/genou, distributeurs à coude.

La Gestion des Déchets de Soins : Le Triage Réglementaire

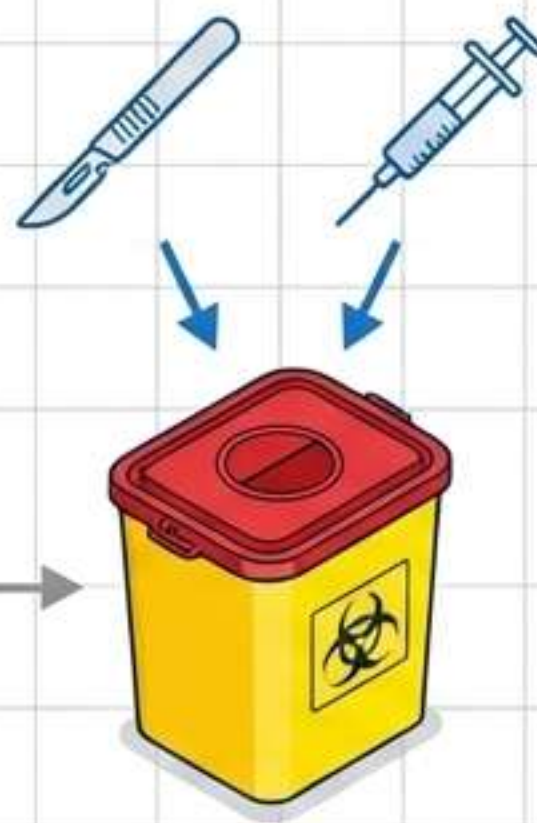


1. Filière Jaune (DASRI)

Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux.

Contenu : Matériels souillés par sang/salive (dents extraites, compresses, tuyaux d'aspiration).

Réceptacle : Bac à déchets clinique.



2. Conteneurs Rigides Spécifiques (OPTC)

Objets Piquants, Tranchants, Coupants.

Contenu : Lames de bistouri, aiguilles.

Réglementation spécifique :
Exige un conteneur rigide spécial (éliminé par société externe)
[Ref: Q2 (2023 EMD)]



3. Filière Noire (DAOM)

Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères.

Contenu : Essuie-mains, emballages généraux.

Réceptacle : Sac plastique
→ poubelle ménagère classique.

Analyse Stratégique des Examens (Exam Pattern Analysis)

Les Cibles Prioritaires (Hautement Répétées)

Le matériel

L'Autoclave de Classe B est systématiquement la bonne réponse pour le stérilisateur (2019, 2023, 2024)

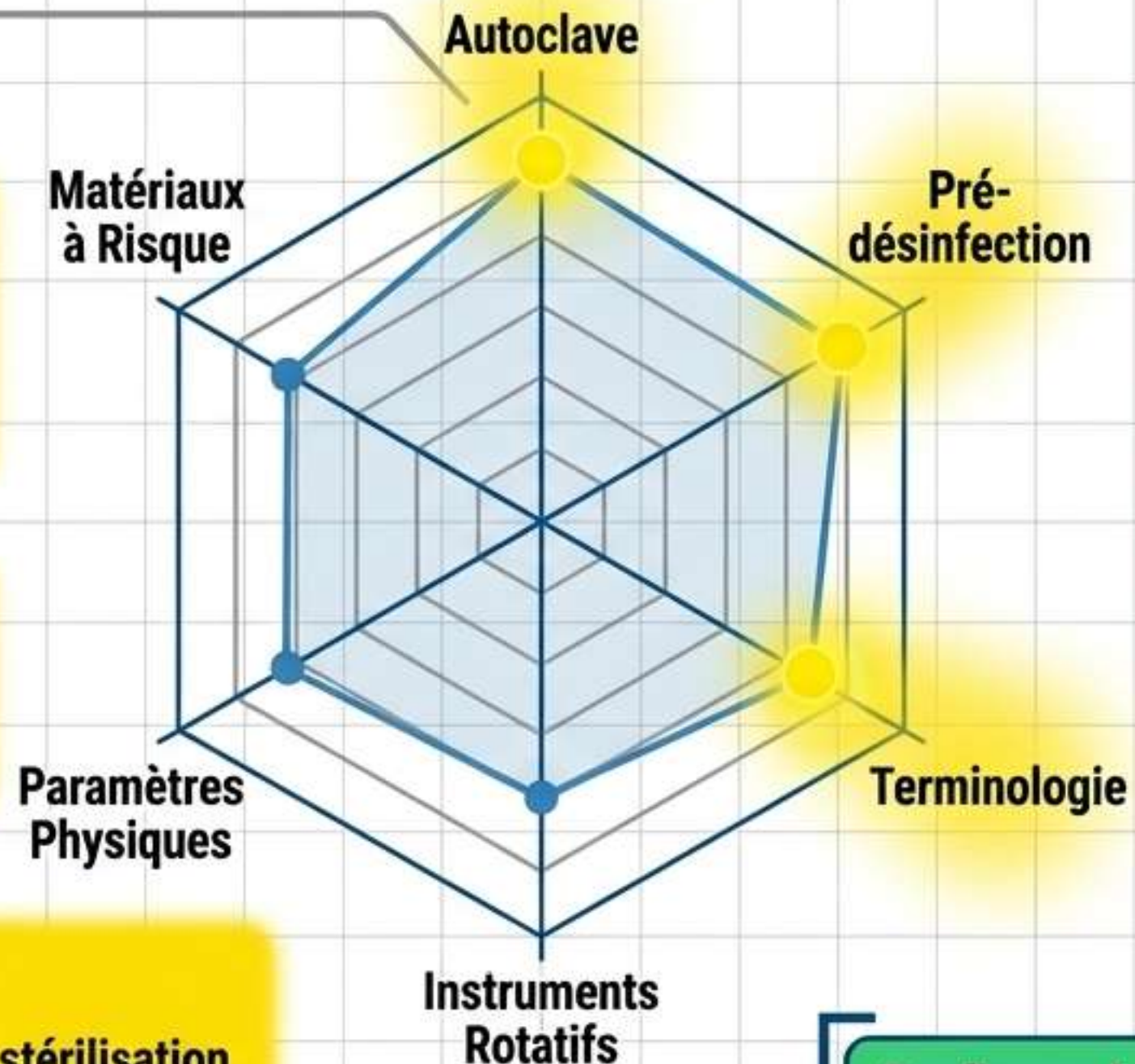
Les paramètres

134°C pendant 18 minutes (Chaleur humide / vapeur d'eau saturée)

Les pièges de définition

La pré-désinfection (facilite le nettoyage, mais ne stérilise pas)

La stérilisation (élimine TOUT)



Les Pièges de Logique à Éviter

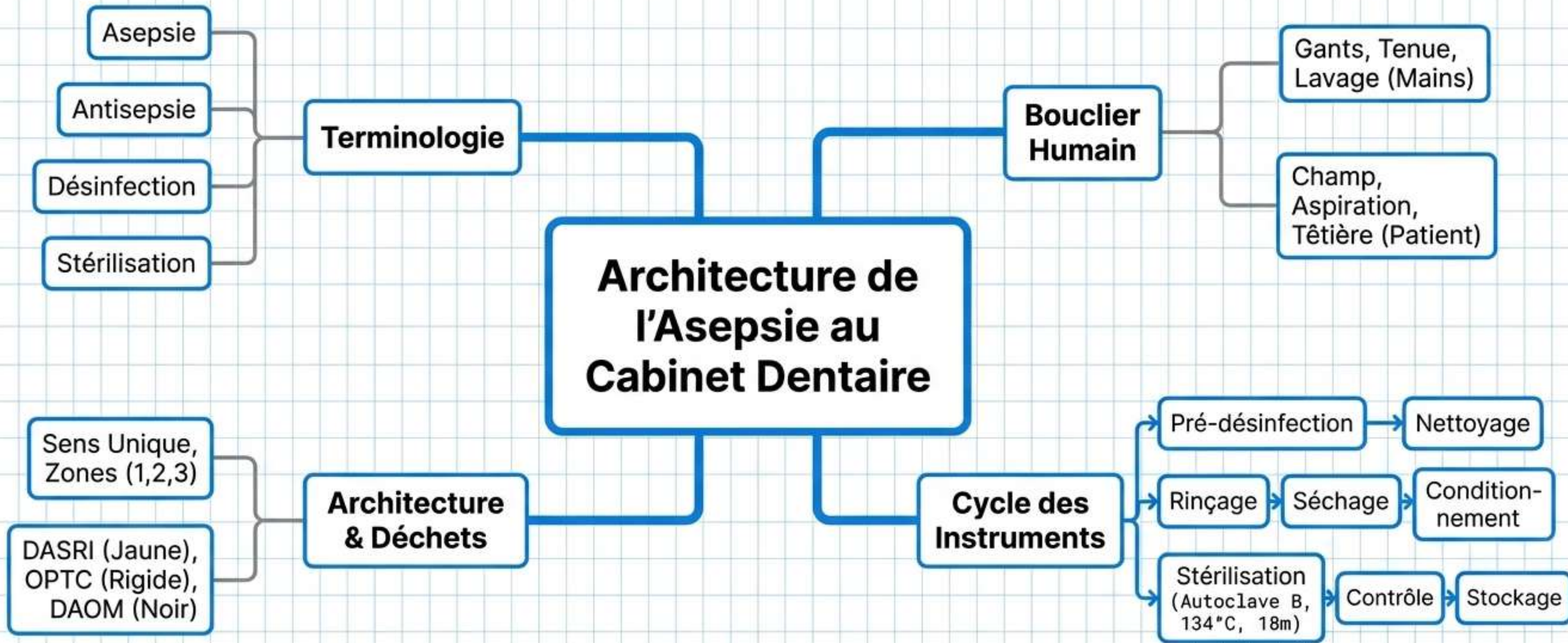
⚠ Croire que les instruments rotatifs ne vont pas à l'autoclave. (Faux : Ils y vont après purge)

⚠ Croire que le nettoyage suffit à détruire toute la flore. (Faux : c'est un acte mécanique préparatoire)

⚠ Confondre les bacs de DASRI et les conteneurs rigides pour OPTC (aiguilles)

Confiance de Couverture : 100%.
La maîtrise du cycle de stérilisation (les 8 étapes) garantit plus de 60% des points sur ce chapitre.

Synthèse Finale : La Carte Mentale (Mind Map)



PDF fully scanned.
100% content coverage confirmed.
No omission detected.